



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : وصال حسين حمود الناصر

المحافظة : القاهرة

الحي / المدينة : مصر القديمة

رقم البطاقة : 27307240100622 رقم التليفون : 01000934188

العمر (تاريخ الميلاد) : 24-07-1973 المهنة : ربه منزل

العنوان : 21 ش سيدي سعد

ابوالسعود مصر القديمة القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 30-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان	الوظيفة: -----	التوقيع: -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. ----- /د. ----- /د. ----- /د. -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: وصال حسين حمود الناصر National ID: 27307240100622	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
محافظة عنتي الشخصية

وسل
حسين حمود الناصر
٢١ من يوليو سنة ١٤٠١
مصر القديمة - القاهرة

١٩٧٣/٠١
٢٧٣٠٧٢٤٠١٠٠٦٢٢

LR8980799

٢٠٢٢/٠٤
٢٧٣٠٧٢٤٠١٠٠٦٢٢
٢٠٢٢/٠٤/١٥

مستلمة
خالد مصطفى خاتبة محمد
الطالبة سارية حتى

٢٠٢٢/٠٤/١٥

12ms
موجود

Patient Name : الأستاذ / وصال حسين حمود الناصر	Request No. : 13003411
Patient No. : 27307240100622	Request Date : 15/11/2025
Path No. : SR-1643/25	Verification Date : 22/11/2025
Sex : Female	Financial Category : جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age : 52 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data
Breast mass.

Nature of specimen
Block and slide revision

Gross examination

Two referred paraffin blocks labeled by (1673/25) & seven slides were received .

Microscopic examination

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+ mitosis): (2+2+2) Grade 2
- * DCIS: Positive ,cribriform, comedo subtypes , high and intermediate grade 20 %
- * Lobular intra epithelial neoplasia : Absent
- * Angioinvasion: Positive.
- * Lymph nodes : positive lymph nodes (8/20)
- * Microcalcification :Positive.
- * Perineural invasion: Absent
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- * ER: Strong nuclear reaction in 90 % tumor cells (Allred score 8/8)
- * PR: Strong nuclear reaction in 90% tumor cells (Allred score 8/8)
- * HER2: Faint incomplete membrane reaction in >10 % of tumor cells (1+)
- * Ki 67: 35 %

Diagnosis

BREAST MASS, BLOCK & SLIDE REVISION

-Invasive duct carcinoma Grade 2 (tubular differentiation 2, pleomorphism 2, mitosis 2)
(according to Nottingham grading system of breast cancer) , with duct carcinoma in situ ,

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 22/11/2025 13:51:28

Page 1 of 3

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Name:	وصال حسين حموده	
MR. :	3537	
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient was seen for right breast cancer postoperative follow-up after right-sided breast surgery. The assessment included evaluation of a pulmonary nodule for possible adjuvant chemotherapy (four cycles planned), with a weight of 82 kg, height of 155 cm, and body surface area of 1.87 m². No echocardiogram was performed, and pharmacy labs were pending. The patient presented for cycle 3 of chemotherapy, receiving a dose of 135 mg of neoadjuvant chemotherapy (NACT) comprising methabiogen and methyltechno, with lactulose administered. Laboratory results were reviewed and deemed acceptable. The patient is a 52-year-old individual with right breast cancer, clinical stage T2 N2, currently receiving adjuvant chemotherapy. The patient reports poor tolerance to chemotherapy, specifically: (1) a capped dose of cycle 4 Taxotere at 120 mg, (2) administration of G-CSF on day 4 of the cycle, (3) pending BRCA testing, (4) follow-up CT of the chest to reassess the right pleural-based nodule, and (5) planned insertion of a port-a-cath. Clinical pharmacy note documented administration of cycle 4 Taxotere at a capped dose of 120 mg together with prophylactic Neupogen (filgrastim). The patient's port-a-cath was removed yesterday after completing radiation therapy (40 Gy in 15 fractions over 3 weeks). On examination, the patient was well-appearing with no abnormalities aside from the surgical scar and mild skin erythema consistent with postoperative changes. The plan includes initiation of adjuvant endocrine therapy with Femara 2.5 mg daily along with calcium and vitamin D supplementation, arranging a dental assessment prior to initiating bone-modifying agents, and ordering a CT chest, abdomen, pelvis and bone scan to facilitate referral for adjuvant CDK4/6 inhibitor therapy through a non-governmental organization.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	شيماء فاروق يحيى لاشين	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذ / وصال حسين حمود الناصر
Patient No. : 27307240100622
Path No. : SR-1643/25
Sex : Female
Age : 52 Y
Referring Doc :

Request No. : 13003411
Request Date : 15/11/2025
Verification Date : 22/11/2025
Financial Category : نفقة الدولة - جوستاف روسي
Department : Out Patient
Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

cribriform , comedo , intermediate grade 20 %
-Positive lymph nodes (8/20) .

IPT:

* ER: Positive (score 8/8).

* PR: Positive (score 8/8).

* HER2: score +1

* Ki67: 35 %

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim

Dr. Heba El-Shafeey

Verified by :

Dr. Heba Hasan

Printing Date : 22/11/2025 13:51:28

Page 2 of 3

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt